

УДК: 616/22-006-08

Г.Б. Адильбаев, ДН.Ахметов, Г.Г.Ким, С.А.Аппазов, Ж.Т. Садык, У.М.Адилханова
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Реабилитация голосовой функции после полного удаления гортани с помощью голосовых протезов

Аннотация. В статье представлены результаты реабилитации голосовой функции у 136 пациентов с раком гортани после ларингэктомии. Трахеопищеводный шунт с голосовым протезом позволил восстановить громкую и звучную речь у 88,3% больных.

Ключевые слова: реабилитация, голосовой протез, ларингэктомия, трахеопищеводный шунт.

Рак гортани составляет около 2% в общей структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями и частота его ежегодно повышается. По отношению к раку ЛОР-органов других локализаций рак гортани составляет 40—60%, заболевают преимущественно мужчины в возрасте от 40 лет и старше. Злокачественные опухоли гортани относятся к категории визуально доступных. В Казахстане ежегодно регистрируются около 440 больных раком гортани (состоят на учете 2701 пациент), однако около 60% больных диагностируются при 111-У стадиях заболевания. В связи с этим традиционным методом лечения больных местнораспространенными формами рака гортани является комбинированное лечение – операция и лучевая терапия в различной последовательности. Основным видом радикального хирургического вмешательства является ларингэктомия. Полное удаление гортани, оправданная с онкологической позиции приводит больного к инвалидности, наносит ему тяжелую психическую травму, лишает его возможности полноценного общения с окружающими. Восстановление голосовой функции является главной задачей реабилитации после полного удаления гортани. Качество жизни у ларингэктомизированных больных во многом зависит от того, насколько он успешно прошел процесс голосовой реабилитации. Восстановление голосовой функции позволит больному вести социально-активный образ жизни, активно продолжить трудовую деятельность. В данное время восстановление голосовой функции проводится несколькими способами: традиционными – с использованием логопедических методов и голосообразующих аппаратов и новыми хирургическими методами с применением голосовых протезов(1,2). По данным различных авторов при логопедическом методе восстановления голоса пищеводным голосом овладевали не более 60% больных. Существенным недостатком пищеводного голоса является его значительное отличие от естественного, менее выразителен, фонация у части больных сопровождается шумом, исходящим из трахеостомы, что ухудшает восприятие речи. При использовании наружных голосовых аппаратов (электронные гортани, транзисторные звукогенераторы) голос получается монотонным, шумным, с металлическим «роботоподобным» оттенком и больные часто отказываются от использования этих устройств.

Таким образом, проблема улучшения качества голосовой функции у ларингэктомизированных больных является актуальной.

Цель работы – оценка роли трахеопищеводного шунтирования с голосовым протезированием в реабилитации голосовой функции ларингэктомизированных больных.

Материал и методы. Под наблюдением находилось 136 больных, которым после операции ларингэктомии произведены трахеопищеводное шунтирование с голосовым протезированием. Третья стадия заболевания была диагностирована у – 97, IV стадия – у 39 больных. Прооперировано в связи с появлением рецидива и продолженного роста опухоли 37 пациентов после радикального курса лучевой терапии (СОД 60-68 Гр), 29 – после предоперационного курса лучевой терапии – СОД 40 Гр, 17 больным первым этапом были произведены оперативные вмешательства. Интраоперационное протезирование было выполнено у 64 больных, отсроченное (с интервалом от 3 месяцев до 4 лет) – у 72.

В работе были применены голосовые протезы Bloom-Singer и Provox (2,3) для длительного использования. Голосовой протез представляет полую трубу, внутренний диаметр составляет 5мм. Эта часть протеза изготовлена из плотного силикона и препятствует сужению шунта. На концах протеза расположены фланцы, которые плотно фиксируют протез в шунте и не дают выпасть при кашле. В протезе Bloom-Singer передний (трахеальный) фланец более плотный, чем внутренний (пищеводный), так как его вводят со стороны трахеи. В протезе Provox обратное соотношение: более плотный пищеводный фланец. В просвете протеза расположен защитный клапан (из более мягкого силикона), который пропускает воздух из трахеи в пищевод и препятствует аспирации пищи в обратном направлении. Для каждого способа введения протезов имеется перфоратор и набор проводников.

Перед протезированием больные были информированы о существующих методах восстановления голоса, о механизме работы протеза, об операции и уходе за протезом, старались продемонстрировать больных, владеющих голосом после трахеопищеводного шунтирования с протезированием. После этого пациенты сознательно выбрали метод реабилитации. У больного не должно быть тяжелых заболеваний легких, размер трахеостомы не должен быть менее 2,0 см.

Первым этапом выполняли ларингэктомию, формировали широкую бесканальную трахеостому. После этого пунктировали заднюю стенку трахеи и переднюю стенку пищевода. С помощью проводника в образованной фистуле устанавливали голосовой протез. У больных после интраоперационного протезирования голос возникал через 3-5 дней после удаления носопищеводного зонда, после отсроченного протезирования – на сле-

дующий день после операции и существенно улучшался через 1-2 недели. Как правило, больные не занимались с логопедом, выполняли простые упражнения, рекомендованные нами. С помощью голосовых протезов удалось восстановить громкую, разборчивую речь у 88,3% пациентов, при этом качество голоса было значительно выше пищевого.

В процессе операции, из-за массивных рубцов трахеи, во время протягивания через шунт протез оторвался и упал в желудок у одного больного. У 8 больных отмечалась аспирация пищи и жидкости через шунт в трахею вследствие деформации защитного клапана и им были заменены голосовые протезы, после этого прекратилось протекание пищи и жидкости. Протез был неправильно подобран у одного пациента, т.к. был короток и поэтому

потребовалось его замена. Для улучшения качества голоса миотомия констрикторов глотки, при отсроченном протезировании, произведены 5 больным. Средний период использования протезов составил – 10,6 месяцев. Установка протеза не осложняла послеоперационное течение. У 8 больных возникли глоточные свищи, которые самостоятельно зажили, а у 1 – фарингостома, требовавшая последующего ушивания.

Таким образом, трахеопищеводное шунтирование с голосовым протезированием может восстановить хороший голос у подавляющего большинства больных, метод безопасен и не ограничивает радикальность онкологического вмешательства и он должен занять ведущее место в реабилитации голосовой функции ларингэктомированных больных.

Список литературы

1. Ольшанский В.О., Решетов И.В., Новожилова Е.Н., Дворниченко В.В. Реабилитация голосовой функции с помощью голосовых протезов после удаления гортани по поводу рака // Вестник оториноларингологии.-2003.- №5.- С.4-7.
2. Ольшанский В.О., Чиссов В.И., Решетов И.В. и др. Ларингэктомию с трахеопищеводным шунтированием и протезированием при раке гортани.- М., 2004.- 184 с.
3. Terada T., Saeki N., Toh K. et all. Voice rehabilitation with Provox voice prosthesis following total laryngectomy for laryngeal and hypopharyngeal carcinoma // Auris Nasus Larynx.- 2007.-Vol.34, N1.- P.65-71.

ТҰЖЫРЫМ

Ғ.Б.Әділбаев, Д.Н.Ахметов, Г.Г.Ким,
С.А.Аппазов, Ж.Г.Садык, У.М.Адилханова
Қазақтың онкология және радиология
ғылыми-зерттеу институті

Summary

G.B.Adilbayev, D.N.Akhmetov., G.G.Kim,
S.A.Appazov, Zh.T.Sadyk, U.M. Adilkhanova
Kazakh Research Institute of Oncology and
Radiology

Көмекейді толық алып тастағаннан кейінгі сөйлеу қабілетін даус пртездері арқылы қалпына келтіру

Мақалада катерлі ісікпен ауырған 136 науқастардың көмекейін алып тастағаннан кейінгі сөйлеу қабілетін қалпына келтіру жұмысының нәтижесі көрсетілген. Өңеш пен кеңірдекті тесіп дауыс пртезін қойған соң 88,3% аурулардың дауысы қалпына келді.

Түйінді сөздер: қалпына келтіру дауыс пртездері, ларингэктомиа, көмекей-өңештік шунт.

Voice rehabilitation of laryngectomized patients with voicepros the sis

The article presents results of voice rehabilitation in 136 patients with cancer of larynx after laryngectomy. Tracheoesophageal anastomosis with voice prosthesis allowed to recover loud, intelligible speech in 88,3% patients.

Keywords: rehabilitation, voice prosthesis, laryngectomy, tracheoesophageal shunt.